

3. 讨 论

近几年来,我国的性传播性疾病仍有蔓延之势,病原体越来越多见。滴虫、念珠菌、细菌性阴道炎向来是临床上常见病、多发病,亦是阴道炎中混合感染致病的主要病原体。本组的标本中单纯性感染性阴道炎以霉菌感染为主(18.3%),其次是加特纳菌感染(9.6%),比例较高,混合感染性阴道炎占 6.5%,呈上升趋势,分析其原因可能与以下因素相关。

滥用抗菌药物引起菌群失调 正常阴道环境应该是乳酸杆菌占优势,pH 值低于 4.5。滥用抗菌药物等因素影响阴道生理环境,改变 pH 值,破坏阴道正常的生理平衡,当阴道内真菌大量繁殖,会导致念珠菌性阴道炎。当加特纳氏菌等细菌取代了阴道内乳酸杆菌的优势地位,则导致细菌性阴道炎的发生。再者,因滴虫的治疗欠彻

底,就易造成病原体错综复杂,混合致病的局面。

在实验室诊断方面 传统方法以盐水涂片法查滴虫、念珠菌、革兰氏染色查淋球菌。盐水涂片法会因取出标本过久或涂量较少而镜下漏诊率偏高。近年,由于 CTB 染色法的应用,大大提高了检测率和准确性。CTB 染色法,染色形态结构清晰,不受温度影响,在寒冷季节可弥补滴虫检出率偏低,念珠菌容易受样本清洁度影响的缺陷,对加特纳氏菌的染色比旧法更清晰,不易漏诊。这样,大大提高了加特纳杆菌的诊断率。

不洁性生活、公共污染、交叉感染是主要的传染方式 加特纳菌主要由性传播引起细菌性阴道炎,如果缺乏性病防治知识或性道德观念淡化,不能自觉抑制性乱行为,就会引起加特纳菌的感染和混合感染性阴道炎的增加,这要引起临床医生的重视。

• 皮 肤 科 •

氧氟沙星的不良反应及药物相互作用

张新江 古力孜乃提 (新疆交通医院皮肤科,乌鲁木齐市 830054)

中国分类号 R969.2

氧氟沙星(OFLX)为第三代氟喹诺酮类广谱抗菌素药物,不仅对革兰阴性菌有强大的抗菌活性,对革兰阳性菌也有较好的抗菌作用;且速效,其强大的对菌体 DNA 旋转酶的抑制作用可在数十分钟内将细菌杀灭,由于其独特的作用机理,深受临床欢迎。但不良反应和药物相互作用日渐增多,作者观察到的和结合文献报道如下。

1. 不良反应

局部反应 有部分患者在静滴 OFLX 时,在数分钟内局部皮肤潮红、刺痛,立即停止治疗后症状可以缓解,较重者可致静脉炎,严重程度与滴速有关;另有出现血管神经性水肿、喉头水肿、散在性紫癜、水疱、斑丘疹、皮肤瘙痒等。

消化系统反应 静注后出现恶心、呕吐、上腹剖隐痛、食欲下降等,多与滴速有关,减慢滴速,症状明显减轻。

神经系统反应 症状多种多样,包括兴奋和抑制。临床表现为头痛、头昏、眩晕、思睡、失眠、惊厥等。作者遇到 2 例患者出现欣快感。用药 30 分钟内出现兴奋多语、飘飘欲仙、全身轻松愉快,停药 12 小时内消失。作用机制可能是 OFLX 抑制神经递质 γ -氨基丁酸与受体结合而使神经兴奋性升高所致。

其它 有一过性嗜酸性细胞增多。粒细胞减少及血

小板计数改变,转氨酶升高,关节疼痛。

2. 相互作用

影响药物代谢 ①与利福平联合,可加速 OFLX 的代谢,使血药浓度大幅度下降;②与氨茶碱合用,可导致氨茶碱的血药浓度有较大幅度的升高而中毒,其机制为 OFLX 抑制肝微粒体的细胞色素 P450 同功酶,引起甲基黄嘌呤类代谢减慢;③OFLX 具有酶抑制作用,与苯妥英钠,卡马西平伍用可导致后者代谢受阻,作用加强,增加肝脏毒性,出现中毒反应;④胃复安、甲氧咪呱可使 OFLX 吸收增加,血药浓度升高;⑤与抗凝血药合用可使后者血药浓度升高,抗凝过度,凝血时间延长,引起出血;⑥与含镁、铝、铁、锌等金属离子制剂合用产生螯合作用,影响吸收而导致 OFLX 血药浓度下降。

对泌尿系统的影响 ①与多粘菌素 E 合用可引起急性肾功能不全,增加肾毒性,应注意肾功能的监测;②与呋喃坦啶合用使后者的毒性增加,对肾功能不全者损害更大;③与万古霉素合用可增强肾毒性,应避免联合应用;④在中性及碱性环境中溶解度低,易在肾小管中形成结晶。

其他 ①与非类固醇消炎镇痛药(除阿斯匹林外)、合并可诱发惊厥、癫痫;②与大环内酯类抗生素合用可增加神经系统的不良反应。